

А.О.Тананян
Национальный Центр онкологии им.В.А.Фанарджяна
Минздрава республики Армения, Ереван

Одномоментное хирургическое лечение больных колоректальным раком с метастазами

Аннотация. В работе представлены результаты одномоментного хирургического лечения больных колоректальным раком с метастазами в различные органы и ткани. Дифференцированный подход с выбором хирургической тактики может служить залогом высокой вероятности благоприятного исхода хирургического лечения колоректального рака.

Ключевые слова: колоректальный рак, метастазы в различные органы и ткани, дифференцированный подход, одномоментное хирургическое лечение.

Введение. Как известно, сложность хирургического лечения колоректального рака (КРР) во многом определяется ранним развитием осложнений в виде метастазов в различные органы и ткани. Метастазы, развившиеся на фоне опухолевого процесса, как правило на 3-й стадии, в значительной мере ухудшают непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения. До настоящего времени нет единого мнения в отношении хирургической тактики при метастазах КРР [1, 4].

Считается, что при плановых операциях в основном выполняется одномоментная резекция участка кишки с опухолью с восстановлением кишечной непрерывности. Однако при метастазах такие операции чреваты дальнейшим развитием опухолевого процесса с усугублением болезни и страданиями больного, с риском повторных оперативных вмешательств. Поэтому во многих клиниках используется одномоментная операция по удалению как самой опухоли, так и метастазированных участков близлежащих органов и тканей [2-3].

Цель исследования - Определить возможность одномоментной хирургической операции у пациентов с колоректальным раком, осложненным метастазами в различные органы и ткани.

Материал и методы. Работа основана на лечении больных с колоректальным раком, осложненным метастазами в различные близлежащие органы и ткани, с применением методики одномоментного хирургического удаления опухоли с участками метастазированных органов и тканей. Поднаблюдением и лечением находились 16 больных, среди которых было 7 пациентов мужского пола и 9 – женского пола. Возрасте больных колебался в пределах от 49 до 80 лет (средний возраст составил $65,1 \pm 1,7$ лет). Локализация опухолевого процесса была в области ободочной и сигмовидной кишки (11 больных) и прямой кишки (5 больных). В 11 случаях первичная опухоль была инфильтрирована во все слои кишечной стенки с прорастанием в прилежащие органы и структуры. При этом метастазы в печень выявлены у 5 больных, в регионарные лимфатические узлы – у 7 больных и в другие органы и ткани – у 4 больных.

Результаты и обсуждение. Оперативному вмешатель-

ству были подвергнуты 14 больных. В двух случаях опухоли оказались неоперабельными. В предоперационный период осуществляли рентгеноскопию органов брюшной полости и ректороманоскопию. Вопрос о первичном восстановлении кишечной непрерывности решался дифференцированно в зависимости от состояния и возраста больного, стадии опухолевого процесса, наличия и степени развития метастазов и сопутствующих заболеваний. Антибиотики широкого спектра действия использовались до, в ходе и после операции с целью подавления патогенной микрофлоры и предотвращения гнойно-септических осложнений. Основываясь на клинических данных, нами была выполнена радикальная операция по удалению опухоли у 14 больных с 3-й стадией КРР с метастазами и локализацией процесса в следующих областях. При выявлении опухоли в ободочной кишке определялись одиночные метастазы в печень (у 3 больных), которые иссекались с одновременным удалением опухолевого участка ободочной кишки. У двух больных из этой группы опухоль проросла в петли тонкого кишечника, в результате чего производилась резекция пораженного участка тонкого кишечника единым блоком с опухолью ободочной кишки. У больных с опухолью в области сигмовидной кишки отмечены метастазы в близлежащие лимфатические узлы (в 5 случаях), а также в тело матки и придатки у больных женского пола (в двух случаях). В этих случаях производилась одномоментная резекция опухоли с маткой и придатками, с удалением пораженных лимфатических узлов и с наложением колостомы или обходных анастомозов.

В 5 случаях локализация опухоли определялась в прямой кишке с метастазами в области брыжейки и в близлежащие лимфатические узлы (в 2 случаях), а также в матку и придатки больных женского пола (в 3 случаях). У этих больных была произведена резекция участка прямой кишки с удалением пораженных лимфатических узлов и части брыжейки, а также матки с придатками. Этим больным накладывались различные колостомы или обходные анастомозы. У всех больных на последнем этапе производилось восстановление проходимости кишечной трубки.

В послеоперационном периоде все больные получали соответствующее интенсивное восстановительное лечение, направленное на профилактику гнойно-септических осложнений, используя противобактериальные препараты широкого спектра действия, с восстановлением и нормализацией водно-электролитного и белкового баланса, с активным поддержанием функций жизненно-важных органов и систем [4, 5].

Послеоперационные осложнения были отмечены в 4 случаях, среди них несостоятельность анастомозов была отмечена в двух случаях, некроз низведенной кишки воз-

нику 1 больного, осложнившись параректальным абсцессом. У одного больного отмечено гнойно-септическое осложнение в области операционной раны с развитием внутрибрюшного абсцесса. Ранняя послеоперационная летальность отмечена в одном случае.

Результаты наших клинических наблюдений не выявили различий в прогнозе хирургического лечения среди больных мужского и женского пола, а также изменений в зависимости от локализации опухолевого процесса, степени распространения на близлежащие органы и ткани. Отдаленные результаты в сроки наблюдений от 12 месяцев до пяти лет были прослежены у 9 пациента из 14 оперированных. Четверо больных выбили из-под наблюдения в связи со сменой места жительства или неявкой на контрольные обследования, двое умерли в сроки от 3 до 5-х лет. Общая послеоперационная летальность составила 3 человека.

Таким образом, при разработке алгоритма диагностики и тактики лечения больных КРР, осложненным метастазами в ближайшие органы и ткани, нами учитывались не только степень распространенности опухолевого про-

цесса и объективная оценка общесоматического статуса, но и оценивались состояние больного, его возраст и возможности комплексного подхода при одномоментном хирургическом лечении данной патологии, что способствовало значительному снижению как числа послеоперационных осложнений, так и летальности [2, 5].

Выводы.

Лечение колоректального рака, осложненного метастазами, позволяет полагать правомерность избирательного и дифференцированного подхода к выбору тактики хирургического лечения. В зависимости от сложности и стадии опухолевого процесса, степени глубины и ареала распространения метастазов, возраста и состояния пациентов, может быть использован одномоментный подход по удалению опухоли и участков метастазированных органов и тканей. Такой подход может служить залогом высокой вероятности благоприятного исхода непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения колоректального рака, осложненного метастазами.

Список литературы

1. Алиев С.А. Тактика хирургического лечения послеоперационных осложнений у больных с обтурационной непроходимостью ободочной кишки опухолевой этиологии // Вестн. хирургии – 1999. - № 3. - С. 66-69.

2. Колесник Е.А., Хворостовский Р.Р., Лаврик Г.В., Губская В.З. Комбинированное лечение больных колоректальным раком с синхронными метастазами в печени с применением циторедуктивных операций и различных режимов химиотерапии // Онкология. - 2008. - №1. - С.36-37.

3. Лихтер М.С., Шелыгин Ю.А. Мультидисципли-

нарный подход к лечению больных колоректальным раком с вовлечением органов мочевыделительной системы // Хирургия им. Н.И.Пирогова. - 2012. - № 12. - С. 34-39.

4. Berretta S., Barbagallo S., Bonanno S. Our experience with the Hartmans operation in colorectal emergencies // Minerva Chir. - 2000. - Vol.55. - P. 247-258.

5. Egi H., Okajama M., Hinoi T. et al. Single-incision laparoscopic colectomy using the Gelport system for early colon cancer // Scand.J.Surg. - 2012. - Vol. 101, N 1. - P. 16-20.

Тұжырым
А.О.Тананян

В.А. Фанарджян атындағы Ұлттық Онкология Орталығы
Армения республикасының денсаулық сақтау
министрлігі, Ереван

Метастаздық колоректальды қатерлі ісігі бар науқастардың бір мезеттегі хирургиялық емі

Бұл жұмыста әр түрлі мүшелер мен тіндерге метастаз берген колоректальдық қатерлі ісігі бар науқастардың бір мезеттегі хирургиялық емінің нәтижелері берілген. Сараланған көзқараспен хирургиялық тактиканы таңдау колоректальдық қатерлі ісігінің хирургиялық емінің қолайлы нәтижеге қол жеткізуіне ықпалын тигізеді.

Түйінді сөздер: колоректальдық қатерлі ісік, әр түрлі мүшелер мен тіндерге метастаз беру, сараланған көзқарас, бір мезеттегі хирургиялық емі.

Summary
A.O.Tananyan

National Center of Oncology im.V.A.Fanardzhyan
Ministry of Health of the Republic of Armenia, Yerevan

Simultaneous surgical treatment of patients with metastatic colorectal cancer

The paper gives the results of simultaneously surgical treatment of patients with colorectal cancer on metastatic in various organs and tissues. The differential manner to the selection surgical tactics perhaps to be high probability of immediate and remote favourable outcomes of surgical treatment of colorectal cancer.

Key words: colorectal cancer, metastatic in various organs and tissues, differential manner, simultaneously surgical treatment.